

Equipe Aurora

O registro não conta toda a história

“Leve as perguntas com você. Este material reúne os conceitos e o caso para que você continue a discussão depois do jogo.” — Iris

O problema que investigamos

Na UTI oncológica, os registros sugerem adesão desigual entre os turnos. A direção quer um novo treinamento; os profissionais apontam duplicidade no prontuário. Ainda não sabemos quanto da lacuna é de documentação e quanto é de execução.

Objetivos da missão

- Distinguir lacuna de registro e lacuna de execução
- Priorizar determinantes do fluxo e dos turnos
- Planejar um piloto e acompanhar alcance e fidelidade

Dados iniciais do caso fictício

Medida	Dado	O que representa
Registro · diurno	52/60	Oportunidades elegíveis com avaliação de risco documentada
Registro · noturno	18/40	Mesmo critério, em oportunidades elegíveis do turno noturno
Observação direta	16/30	Oportunidades observadas com todos os componentes essenciais executados
Treinamento	28/32	Profissionais elegíveis que participaram; isso não comprova execução

Simulação educacional. Dados, pacientes e personagens fictícios. As aplicações dos referenciais são interpretações didáticas, não recomendações clínicas ou um instrumento validado.

Do conhecimento à mudança

Knowledge-to-Action

O KTA articula criação do conhecimento e um ciclo de ação. Identificar a lacuna, adaptar ao contexto, investigar barreiras, escolher estratégias, monitorar, avaliar e sustentar são atividades que podem ser revisitadas.

No seu caso: Distinguir lacuna de registro e de execução orienta o primeiro teste.

Evite: Tratar o ciclo como uma lista rígida ou presumir que publicar o protocolo encerra a implementação.

Base: Graham et al., 2006

CFIR atualizado

O CFIR organiza determinantes em cinco domínios. Serve para investigar barreiras e facilitadores; não escolhe automaticamente a estratégia nem substitui a avaliação dos resultados.

Domínios: inovação; contexto externo; contexto interno; indivíduos; processo.

No seu caso: Duplicidade, acesso e habilidades podem coexistir; comparem relatos e observação.

Evite: Confundir uma barreira com a estratégia para enfrentá-la, ou classificar um relato sem definir o contexto do projeto.

Base: Damschroder et al., 2022; Reardon et al., 2025

PARIHS e i-PARIHS

O PARIHS destaca evidência, contexto e facilitação. O i-PARIHS articula inovação, destinatários e contexto por meio da facilitação ativa: avaliar necessidades, alinhar condições e apoiar a mudança.

A facilitação exige ações: avaliar necessidades, negociar condições, preparar pessoas e acompanhar a incorporação. Nomear alguém não equivale a facilitar.

No seu caso: Negociar um fluxo com os turnos é uma ação; nomear a facilitadora não basta.

Evite: Designar uma facilitadora e presumir que o cargo, sem ações e apoio, resolve a implementação.

Base: Harvey e Kitson, 2016

Planejar e avaliar com RE-AIM

O RE-AIM apoia planejamento e avaliação em níveis individual e organizacional. Definam unidade de análise, numerador, denominador, fonte e momento; investiguem também representatividade.

Dimensão	Pergunta de estudo
Alcance	Participação e perfil das pessoas destinatárias.
Efetividade	Efeitos da intervenção, inclusive indesejados.
Adoção	Participação de serviços e profissionais que iniciam a prática.
Implementação	Execução, adaptações e custos.
Manutenção	Continuidade em níveis individual e organizacional.

Aplicação à missão

Alcance simulado: $18/24 = 75\%$; diurno $14/16 = 87,5\%$; noturno $4/8 = 50\%$. O total esconde diferenças. Investigue perfil e oportunidades antes de atribuir a diferença ao turno.

Ficha de um indicador

Registre: dimensão ou desfecho; unidade de análise; numerador; denominador; fonte; momento; responsável; critério para revisar o plano. Analise quem ficou de fora e os efeitos indesejados.

Usar uma taxa global para ocultar grupos não alcançados, ou confundir adoção inicial com continuidade.

Base: Glasgow et al., 2019. As definições abrangem níveis individual e organizacional; as medidas dependem do projeto.

Desfechos de implementação

A taxonomia de Proctor distingue resultados da implementação de resultados dos serviços e clínicos. Cada medida precisa indicar o que é avaliado, por quem, em que nível e momento.

Desfecho	O que investigar
Aceitabilidade	Percepção de que a prática é satisfatória.
Adoção	Intenção, decisão inicial ou início do uso.
Adequação	Percepção de pertinência e compatibilidade.
Viabilidade	Possibilidade de executar no contexto.
Fidelidade	Execução conforme previsto.
Custo	Impacto financeiro da implementação.
Penetração	Integração nos serviços e subsistemas.
Sustentabilidade	Manutenção ou institucionalização.

Prioridade de estudo da sua equipe

Fidelidade: observe oportunidades elegíveis e os componentes essenciais executados. Compare observação e registro. Defina o critério de completude, quem audita e o período; uma tela preenchida não comprova o cuidado.

Não confunda as medidas

Resultado clínico: mudança na condição de saúde, como ocorrência de lesão por pressão. Resultado de serviço: qualidade ou funcionamento da assistência. Desfecho de implementação: incorporação da prática. Eles podem se relacionar, mas um não comprova os demais nem estabelece, sozinho, causalidade.

Base: Proctor et al., 2011 e 2023.

Retome a discussão

O contexto mudou

A TI só poderá alterar o prontuário daqui a seis semanas. O noturno pede uma solução provisória sem um terceiro registro.

Perguntas para revisar seu raciocínio

- A equipe distinguiu registro de execução?
- A estratégia incluiu os dois turnos e preservou componentes essenciais?
- O indicador permite investigar fidelidade sem inferir causalidade clínica?
- Qual dado sustentou a escolha? Que nova evidência faria você revisar o plano?
- Distinguiu determinante, estratégia e desfecho? Descreva um exemplo da missão.
- Como preservou os componentes essenciais e adaptou o fluxo ao contexto?

Anotações após a discussão

Registre a estratégia escolhida, uma limitação apontada na discussão, um indicador completo e o próximo passo. Retome também a devolutiva da mediação no diário do jogo.

Este resumo apresenta o caso e os conceitos; não reproduz automaticamente as decisões ou devolutivas digitadas na partida.

Meu próximo passo: _____

Evidência que ainda preciso buscar: _____

Indicador e critério de revisão: _____

Textos-base e localizadores

Graham et al., 2006. Lost in knowledge translation: time for a map?. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 26(1), 13–24.

Localizador: Modelo KTA e descrição do ciclo de ação

<https://doi.org/10.1002/chp.47>

Damschroder et al., 2022. The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, 17, 75.

Localizador: Tabela 3: domínios e construtos atualizados

<https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>

Reardon et al., 2025. The CFIR User Guide: a five-step guide for conducting implementation research using the framework. *Implementation Science*.

Localizador: Passos 1–3: definir domínios, coletar e analisar dados

<https://doi.org/10.1186/s13012-025-01450-7>

Harvey e Kitson, 2016. PARIHS revisited: from heuristic to integrated framework for the successful implementation of knowledge into practice. *Implementation Science*, 11, 33.

Localizador: Tabela 2, Tabela 3 e seção The facilitation construct

<https://doi.org/10.1186/s13012-016-0398-2>

Glasgow et al., 2019. RE-AIM Planning and Evaluation Framework: Adapting to New Science and Practice With a 20-Year Review. *Frontiers in Public Health*, 7, 64.

Localizador: Seção The RE-AIM dimensions: definitions, evolution, and examples

<https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00064>

Proctor et al., 2011. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health*, 38, 65–76.

Localizador: Tabela 1 e seção Taxonomy of Implementation Outcomes

<https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7>

Proctor et al., 2023. Ten years of implementation outcomes research: a scoping review. *Implementation Science*, 18, 31.

Localizador: Conceptualization e discussão das relações entre estratégias e desfechos

<https://doi.org/10.1186/s13012-023-01286-z>

Material preparado com auxílio de inteligência artificial. A leitura das fontes e a análise acadêmica permanecem com docentes e discentes.